

SELF MANA- GEMENT

DIABETES

Strategi
peningkatan
Self -
management
pasien
Diabetes
mellitus
melalui peran
keluarga



SELF MANAGEMENT DIABETES

TIM PENYUSUN

Alfi Elisa Sahidah

DOSEN PEMBIMBING

Eko Budi Santoso, S.Kep., Ns., M.Kes

HAK CIPTA

E-Booklet: Self-Management Diabetes

Media Edukasi untuk Penderita Diabetes Melitus

© 2026 Alfi Elisa Sahidah & Eko Budi Santoso

E-booklet ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dalam bentuk
apapun

tanpa izin tertulis dari Penulis.

Telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan HAM RI

Nomor Pencatatan: 001353446

Tanggal Pencatatan: 16 Juli 2026



Kata Pengantar



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan E-booklet dengan judul “Self-Management Diabetes”, sebagai media yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir S1 Keperawatan.

Dalam E-booklet ini dijabarkan bagaimana pengaruh edukasi keperawatan berbasis keluarga dengan media E-booklet terhadap peningkatan self-management pasien diabetes melitus, sehingga nantinya dapat dapat bermanfaat bagi peningkatan maupun perubahan pasien diabetes melitus dalam melakukan pengelolaan penyakitnya.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Eko Budi Santoso, S.Kep., Ns., M.Kes. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, koreksi serta saran hingga terwujudnya E-booklet ini.

Terimakasih dan penghargaan saya sampaikan pula kepada yang terhormat:

- ◀ **Dr. Ahmad Hariyanto, M.Si..** Selaku Rektor Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya
- ◀ **Ariska Putri Hidayathillah, S.Kep.,Ns., M. Epid** Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya.
- ◀ **Eko Budi Santoso, S.Kep., Ns., M.Kes.** Selaku Dosen Pembimbing
- ◀ Para dosen dan staff pendidikan di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya
- ◀ Orang tua dan keluarga yang telah memberi dukungan baik melalui doa dan dukungan secara fisik.

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	02
	Daftar Isi	03
01	Pendahuluan	05
	<u>1.1 Latar Belakang</u>	06
02	Diabetes Melitus	07
	<u>2.1 Definisi</u>	08
	<u>2.2 Etiologi/Penyebab</u>	09
	<u>2.3 Gejala</u>	09
	<u>2.4 Faktor Risiko</u>	10
	<u>2.5 Komplikasi</u>	10
	<u>2.6 Klasifikasi</u>	11
03	Self-Management Diabetes	12
	<u>3.1 Definisi</u>	13
	<u>3.2 Point Self-Management</u>	13
	<u>3.2.1 Diet Sehat</u>	13
	<u>3.2.2 Aktivitas Fisik</u>	15
	<u>3.2.3 Kepatuhan Minum Obat</u>	16
	<u>3.2.4 Monitoring Gula Darah</u>	16
	<u>3.2.5 Perawatan Kaki</u>	17

04	Peran Keluarga	18
	4.1 <u>Definisi</u>	19
	4.2 <u>Tujuan</u>	19
	4.3 <u>Dukungan Emosional</u>	19
	4.4 <u>Bentuk Peran Keluarga</u>	20
	4.5 <u>Hambatan</u>	21
05	Penutup	22
	5.1 <u>Kesimpulan</u>	23
	5.2 <u>Saran</u>	23
06	Daftar Pustaka	24



01

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus masih menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia, dan meningkat di Negara-negara berkembang. Diabetes melitus atau yang biasa dikenal dengan sebutan kencing manis termasuk dalam kategori penyakit menahun atau penyakit yang dapat diderita seumur hidup. Penyebab terjadinya Diabetes melitus (DM) yaitu adanya gangguan metabolisme pada organ pankreas. Peningkatan kadar gula darah merupakan tanda terjadinya gangguan pada pankreas, hal tersebut terjadi karena produktivitas pankreas yang menurun sehingga menyebabkan produksi insulin menurun.

Pengendalian diabetes melitus sangat bergantung pada kemampuan pasien dalam melakukan self-management. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak pasien dengan diabetes melitus masih memiliki tingkat efikasi diri dan perilaku perawatan diri yang rendah, sehingga berdampak pada buruknya kontrol gula darah. Self-management adalah perilaku atau cara seseorang dalam memelihara dirinya sendiri. Self-management mencakup bagaimana individu menentukan dan memilih apa yang akan dilakukan, memonitor perilakunya, mengevaluasi apakah perilaku tersebut efektif dalam mencapai tujuan. Dukungan sosial terutama dukungan yang baik dari keluarga dapat meningkatkan self-management penderita diabetes melitus.

02

Diabetes Melitus





2.1 Definisi

Diabetes melitus atau yang biasa dikenal dengan sebutan kencing manis termasuk dalam kategori penyakit menahun atau penyakit yang dapat diderita seumur hidup. ditandai dengan peningkatan kadar gula darah, yang apabila berlanjut akan menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal dan saraf.



2.2 Etiologi/ Penyebab

Diabetes melitus dapat terjadi karena kekurangan cairan dan kekurangan produksi insulin, sehingga saat glukosa masuk kedalam tubuh dia tidak dapat masuk kedalam sel karena tubuh tidak menghasilkan insulin atau jumlah insulin yang dibutuhkan kurang dari normal sehingga menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat (Ns. Haryati et al., 2023).



2.3 Gejala

Gejala Umum:

- Sering buang air kecil (Poluria)
- Sering merasa haus sehingga banyak minum (Polidipsi)
- Perasaan lapar terus menerus yang menyebabkan banyak makan (Polifagia)

Gejala Tambahan:

- Mengalami penurunan berat badan secara tiba-tiba
- Lemas, mudah lelah, mudah mengantuk, kesemutan dan gatal
- Penglihatan kabur
- Mengalami penyembuhan luka yang buruk
- Mengalami disfungsi ereksi pada penderita pria
- Mengalami rasa gatal pada kelamin penderita wanita



2.4 Faktor Risiko

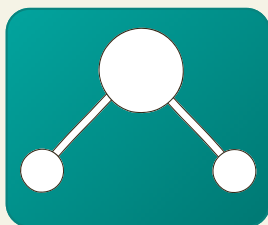
Faktor risiko kejadian diabetes melitus terdiri dari beberapa faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah:

Faktor yang dapat diubah:

- Berat badan berlebihan
- Obesitas abdominal (penumpukan lemak di daerah perut)
- Kurangnya aktifitas fisik
- Hipertensi atau tekanan darah tinggi
- Dislipidemia (tingginya lemak dalam darah seperti kolesterol tinggi)
- Diet yang tidak sehat dan tidak seimbang
- Kondisi pre diabetes
- Merokok.

Faktor yang tidak dapat diubah:

- Ras/Etnis (beberapa kelompok ras/etnis memiliki risiko genetik yang lebih tinggi terkena DM)
- Umur (risiko DM meningkat seiring bertambahnya usia)
- Jenis kelamin (meskipun risiko DM dapat memengaruhi baik pria maupun wanita, ada peningkatan risiko tertentu pada wanita dengan riwayat kehamilan yang sulit)
- Riwayat keluarga
- Riwayat melahirkan bayi > 4000g
- Riwayat lahir BBLR (Bayi berat badan lahir rendah)



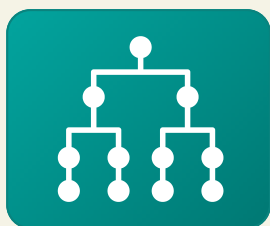
2.5 Komplikasi

Komplikasi Mikrovaskuler:

- Kerusakan sistem saraf (neuropati)
- Kerusakan sistem ginjal (nefropati)
- Kerusakan mata (retinopati)

Komplikasi Makrovaskuler:

- Penyakit jantung
- Stroke
- Penyakit pembuluh darah perifer



2.6 Klasifikasi

1. Diabetes Melitus Tipe 1

Tipe ini dikenal dengan diabetes autoimun atau diabetes awal usia. pada tipe ini sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel pankreas, sehingga berefek pada berhentinya produksi insulin. biasanya DM tipe ini ditemui pada usia muda dan gejala yang ditimbulkan berkembang dengan cepat.

2. Diabetes Melitus Tipe 2

Pada tipe ini kelebihan glukosa disebabkan karena adanya penurunan produksi insulin dan tubuh tidak mampu merespon insulin dengan baik. pada tipe ini terjadi komplikasi lebih tinggi. komplikasi tersebut berupa obesitas, hipertensi, kolesterol, dll.

3. Diabetes Melitus Tipe lain

Pada tipe ini kenaikan gula darah diakibatkan oleh faktor genetik dan sindrom genetik yang berhubungan dengan penyakit DM. Obat-obatan dan bahan kimia (seperti dalam pengobatan HIV/AIDS atau pasca transplantasi organ) dapat memicu diabetes melitus tipe ini.

3. Diabetes Gestasional

Diabetes gestasional adalah masalah yang timbul selama kehamilan berupa intoleransi glukosa, baik adanya riwayat sebelum kehamilan maupun baru terjadi setelah kehamilan.

Untuk skrinning DM gestasional direkomendasikan tes toleransi glukosa oral (OGTT) pada minggu ke-24 dan ke-28 kehamilan, tetapi untuk ibu hamil yang memiliki risiko tinggi makan skrinning dilakukan lebih awal pada masa kehamilan.

03

Self- Management Diabetes





3.1 Definisi

Self-management adalah perilaku atau cara seseorang dalam memelihara dirinya sendiri. Self-management mencakup bagaimana individu menentukan dan memilih apa yang akan dilakukan, memonitor perilakunya, mengevaluasi apakah perilaku tersebut efektif dalam mencapai tujuan.

3.2 Point Self Management

3.2.1 Diet Sehat

Semua makanan bisa dinikmati, hanya saja jumlah dan jenisnya perlu disesuaikan. Diet untuk penderita diabetes adalah menu yang sehat dan seimbang. Artinya, komposisi karbohidrat, lemak, dan proteinnya dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan kesehatan.

Tujuan:

- Menjaga kadar gula darah tetap normal
- Mengontrol berat badan
- Mengurangi risiko komplikasi

Prinsip 3J:

a. Jumlah

Upayakan jumlah makan setiap harinya adalah sama. porsi makan yang berlebihan akan menaikkan gula, sementara menurunkan porsi bisa menurunkan kalori yang masuk. menu yang seimbang harus terdiri dari 50% karbohidrat, 20%, dan 30% lemak.

b. Jadwal

Makan teratur 3 kali sehari dengan selingan sehat bila diperlukan.

Contoh waktu makan:

-  **Sarapan pagi** Jam 06.00-07.00
-  **Makan siang** Jam 12.00-13.00
-  **Makan malam** Jam 18.00-19.00
-  **Kudapan** Jam 09.00, 15.00, 21.00

c. Jenis

Makanan terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. selain itu anda juga masih membutuhkan sejumlah vitamin dan mineral. Pilihlah makanan yang tinggi akan serat, rendah gula, dan rendah lemak jenuh.

Makanan yang dianjurkan:

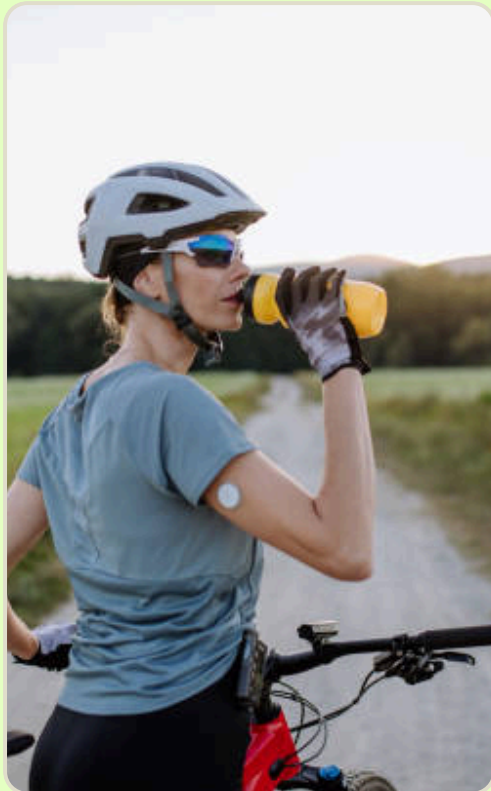
- Sayuran hijau
- Buah rendah gula (apel, pir, pepaya)
- Ikan
- Ayam tanpa kulit
- Tahu dan Tempe
- Nasi merah
- Oatmeal

Makanan yang dibatasi:

- Minuman manis
- Kue dan permen
- Makanan cepat saji
- Gorengan berlebihan
- Minuman bersoda

Tips untuk keluarga:

- Membantu menyiapkan makanan sehat
- mengingatkan jadwal makan
- Mengurangi penyediaan makanan tinggi gula di rumah



3.2.2 Aktivitas Fisik

Olahraga bagi penderita diabetes adalah olahraga aerobik atau olahraga yang berirama teratur. Cukup lakukan aerobik secara rutin 30 menit sehari selama 5-7 hari dalam seminggu. Mulailah dengan 10 menit per hari, kemudian tiap minggu ditingkatkan 5 menit sampai akhirnya mencapai 30 menit.

Jenis aktivitas fisik:

- Jalan kaki
- Senam diabetes
- Bersepeda
- Berenang
- Peregangan kaki

Manfaat

- Menurunkan gula darah
- Menjaga berat badan ideal
- Meningkatkan kekuatan otot
- Melancarkan sirkulasi darah
- Mengurangi stres

Hal yang harus diperhatikan:

- Minum air putih yang cukup
- Gunakan alas kaki yang sesuai dan jika perlu peralatan pelindung lainnya.
- Hindari berolahraga di cuaca yang sangat panas atau dingin
- Hentikan olahraga bila merasa pusing atau lemas
- Periksa kondisi kaki setelah berolahraga
- Hindari olahraga selama periode kontrol metabolisme buruk

Peran keluarga:

- Menemani pasien berolahraga
- Memberikan motivasi
- Mengingatkan jadwal olahraga

3.2.3 Kepatuhan Minum Obat

Pengobatan diabetes harus dilakukan secara rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan.

- | | |
|--|---|
|  Tujuan | <ul style="list-style-type: none"> • Mengontrol gula darah • Mencegah komplikasi • Menjaga kondisi tubuh tetap stabil |
|  Hal yang harus diperhatikan | <ul style="list-style-type: none"> • Minum obat sesuai jadwal • Jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter • Perhatikan dosis obat • Simpan obat sesuai petunjuk |
|  Tips agar tidak lupa minum obat | <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan alarm • Buat Jadwal minum obat • Simpan obat di tempat yang mudah terlihat • Minta bantuan keluarga untuk mengingatkan |
|  Peran keluarga | <ul style="list-style-type: none"> • Mengingatkan jadwal obat • Membantu menyiapkan obat • Mengawasi kepatuhan pasien |

3.2.4 Monitoring Gula Darah

Monitoring gula darah dilakukan untuk mengetahui apakah kadar gula darah terkendali atau tidak.

Pemeriksaan	Nilai Target
Sebelum makan	80-130 mg/dL
2 jam setelah makan	< 180 mg/dL

- | | |
|--|---|
|  Manfaat | <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui kondisi gula darah • Membantu evaluasi pengobatan • Mencegah komplikasi • Mengetahui pengaruh makanan dan aktivitas terhadap gula darah |
|--|---|

 Waktu monitoring

- Sebelum makan
- Dua jam setelah makan
- Saat merasa lemas atau pusing
- Sesuai anjuran tenaga kesehatan

 Peran keluarga

- Mengetahui kondisi gula darah
- Membantu evaluasi pengobatan
- Mencegah komplikasi
- Mengetahui pengaruh makanan dan aktivitas terhadap gula darah

3.2.5 Perawatan Kaki

Kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan saraf dan aliran darah sehingga luka pada kaki sulit sembuh.

 Tujuan

- Mencegah luka
- Mencegah infeksi
- Mencegah amputasi

 Tips perawatan kaki

- Cuci kaki setiap hari
- Gunakan air hangat
- Keringkan sela-sela jari kaki
- Gunakan alas kaki
- Periksa kaki setiap hari
- Potong kuku dengan hati-hati

 Tanda bahaya pada kaki

Segera periksa ke fasilitas kesehatan bila terdapat:

- Luka
- Bengkak
- Kemerahan
- Nyeri
- Keluar cairan atau nanah

 Peran keluarga

- Membantu memeriksa kondisi kaki
- Mengingatkan penggunaan alas kaki
- Membantu perawatan luka bila diperlukan

04

Peran Keluarga



4.1 Definisi

Keluarga merupakan orang terdekat yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengelolaan Diabetes melitus. Dukungan sosial terutama dukungan yang baik dari keluarga dapat meningkatkan self-management penderita diabetes melitus.

4.2 Tujuan

Tujuan Dukungan Keluarga

- Membantu pasien mengontrol gula darah
 - Meningkatkan kepatuhan pengobatan
 - Memberikan motivasi kepada pasien
 - Membantu pasien menjalani pola hidup sehat
 - Mencegah terjadinya komplikasi diabetes
 - Meningkatkan kualitas hidup pasien
-

4.3 Dukungan Emosional

Dukungan emosional membantu pasien merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjalani pengobatan.



Bentuk Dukungan Emosional

- Mendengarkan keluhan pasien
- Memberikan perhatian
- Menemani pasien saat kontrol
- Memberikan rasa nyaman



Dampak Dukungan Emosional

- Mengurangi stres
- Meningkatkan semangat hidup
- Membantu menjaga kestabilan gula darah

4.4 Bentuk Peran Keluarga



A. Keluarga sebagai motivator

Keluarga berperan memberikan semangat dan dukungan kepada pasien agar tetap menjalani pengobatan dengan baik.

Bentuk dukungan motivasi:

- Memberikan semangat kepada pasien
- Mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan
- Memberikan perhatian dan kepedulian
- Menghindari perkataan yang menyalahkan pasien



B. Keluarga sebagai edukator

Keluarga berperan dalam membantu pasien memahami pentingnya pengelolaan diabetes.

Bentuk dukungan edukasi:

- Mengingatkan jadwal kontrol
- Mengingatkan pola makan sehat
- Membantu pasien memahami informasi kesehatan
- Memberikan informasi tentang diabetes



C. Keluarga sebagai fasilitator

Keluarga membantu menyediakan kebutuhan pasien dalam menjalani self-management diabetes.

Bentuk dukungan fasilitas:

- Menyediakan makanan sehat
- Membantu menyediakan obat
- Mengantar pasien kontrol ke fasilitas kesehatan
- Menyediakan alat cek gula darah bila memungkinkan



D Keluarga sebagai pengawas

Keluarga membantu memantau kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan dan pola hidup sehat.

Bentuk dukungan pengawas:

- Mengingatkan jadwal minum obat
- Mengawasi pola makan pasien
- Mengingatkan aktivitas fisik
- Membantu memantau hasil gula darah

4.5 Hambatan

➤ Berikut beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi dukungan keluarga:

- Kurangnya pengetahuan keluarga tentang diabetes
- Kesibukan anggota keluarga
- Kurangnya komunikasi
- Pasien merasa bosan menjalani pengobatan

➤ Cara mengatasi hambatan:

- Memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga
- Melibatkan seluruh anggota keluarga
- Membuat jadwal pengobatan bersama
- Memberikan dukungan secara konsisten

05

Penutup





5.1 Kesimpulan

Diabetes melitus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara total akan tetapi penderita dapat mengelola atau mengontrol kondisi yang dialami agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat. Pengelolaan yang tidak tepat pada penderita DM dapat menimbulkan beberapa komplikasi yang berbahaya bagi penderita. Hal tersebut membuktikan seberapa pentingnya penerapan Self-management pada pasien Diabetes Melitus.

Pasien diabetes melitus yang mendapatkan dukungan yang tinggi dari keluarga akan memberi pengaruh yang besar terhadap peningkatan self-management. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dukungan keluarga berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan pasien dalam mengatasi penyakit secara efektif.

5.2 Saran

Diharapkan dengan adanya E-booklet ini baik keluarga maupun pasien dapat memahami self-management diabetes melitus dan mampu menerapkannya secara efektif.

Daftar Pustaka

Evi, M.H., Rugun, T. 2023. Monograf Faktor Resiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2. Kab. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Poltekkes Tanjungkarang.

Kasmawati, H., et al. 2023. Farmakoterapi Penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 Tinjauan Terapi Konvensiobal dan Terapi Herbal. Yogyakarta: Deepublish Digital

Marasabessy, N.B., et al. 2020. Modul Pencegahan Penyakit Diabetes Melitus (DM) Tipe 2. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management

Naningsih, A., et al. 2025. Edukasi dan Manajemen Diabetes Melitus. Kab. Purbalinga: Eureka Media Aksara

Ns. Haryati., et al. 2023. Pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan penyakit Diabetes Melitus. Kab. Purbalinga: Eureka Media Aksara

PERKENI. 2021. Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus tipe 2 di Indonesia. Indonesia: PB PERKENI

PERKENI. 2024. Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus tipe 2 di Indonesia. Indonesia: PB PERKENI

Rif'at, I.D., Yesi, H.N., Ganis, I. 2023. Gambaran Komplikasi Diabetes pada Penderita Diabetes Melitus. Jurnal Keperawatan Profesional (JKP) Vol. 11 No. 1

Suryanti., et al. 2025. Diabetes Mellitus dan Pencegahan Komplikasi. Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang

WHO. 2025. Diabetes, from https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1, 17 Juli 2026 pukul 18.33

The background is a high-contrast, abstract composition. It features a black base with several diagonal, white, brush-stroke-like lines that create a sense of movement and texture. A solid pink rectangular block is positioned in the upper-middle section, containing the text 'SELF-MANAGEMENT'. Below this, a white rectangular block contains the word 'DIABETES'. A thin white horizontal line spans the width of the page just below the title blocks.

SELF-MANAGEMENT

DIABETES